

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

RANTUDIL, 60 mg, gélules

1. Nom et Adresse et Raison Sociale du Demandeur

BIAL – Portela & C^a, S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

2. Nom et Adresse du Laboratoire Pharmaceutique Fabricant

- Fabricant, lieu de contrôle et conditionnement, libération du lot:

BIAL – Portela & C^a, S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

3. Nom et Adresse du Représentant au Cameroun

Pierre FANDJA
BP 20377, Yaoundé, Cameroun

4. Nom et Adresse du Pharmacien Interlocuteur au Cameroun

Dr EYONG OROCK HANNY OROCK
heyongorock@yahoo.com
Résidant à Yaoundé, Cameroun, diplômé de la Faculté de PORT HARCOURT et inscrit à l'Ordre National des Pharmaciens du CAMEROUN sur le titre n° 515 agissant en son nom et pour son compte personnel.

5. Nom du Produit

RANTUDIL, 60 mg, gélules

6. Dénomination Commune Internationale

Acémétacine.

7. Nom Chimique et Famille Pharmacologique

Acémétacine, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, silice colloïdal anhydre, talc, gélatine, jaune de quinoléine (E104), indigotine (E132), dioxyde de titane (E171) et eau purifiée.

8. Numéro d'autorisation de mise sur le marché au Portugal, valide, et date d'obtention dans le pays fabricant et le pays demandeur

9510735, 9510727, 4560793, 4560892. Date d'obtention: 1980-07-22

9. Lieu de Fabrication et de Conditionnement

BIAL – Portela & C^a, S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

10. Liste des substances vénéneuses

Non applicable.

11. Form et Présentation

Gélules. Boîte de 20 gélules sous blisters de PVC/Aluminium.

12. Classe thérapeutique

Code ATC : M01AB11

13. Composition unitaire détaillée

Chaque gélule contient 60 mg d'acémétacine.

Liste des excipients

Lactose monohydraté (80 M) - 36,20 mg

Lactose monohydraté (200 M) – 75,60 mg

Stéarate de magnésium – 3,70 mg

Silice colloïdal anhydre – 0,80 mg

Talc – 3,70 mg

Gélule :

Corps

Gélatine - q.s.p. 30 mg

Jaune de quinoléine (E104) - 0,005-0,015 mg

Indigotine (E132) - 0,005-0,015 mg

Dioxyde de titane (E171) - 0,30-0,85 mg

Eau - 3,9-4,8 mg

Tête

Gélatine - q.s.p. 20 mg

Jaune de quinoléine (E104) - 0,040-0,060 mg

Indigotine (E132) - 0,070-0,090 mg

Dioxyde de titane (E171) - 0,25-0,45 mg

Eau - 2,6-3,2 mg

14. Propriétés

Propriétés pharmacodynamiques:

L'acémétacine est un anti-inflammatoire non-stéroïdien du groupe des dérivés indoliques.

L'indométacine, médicament standard de ce groupe, est l'un des anti-inflammatoires les plus étudiés, étant ainsi une référence dans les essais de nouveaux anti-inflammatoires.

Cette vaste utilisation permet de documenter son efficacité, ainsi que son incidence appréciable d'effets indésirables suite à la prise d'indométacine. L'acémétacine est un dérivé indolique synthétisé prétendant réduire l'incidence de ces effets indésirables, tout en préservant son efficacité. La vaste expérience clinique accumulée avec l'administration de ce traitement, ainsi que la bibliographie scientifique qui lui est dédiée, confirment la

réalisation de ce desideratum. Les actions pharmacologiques les plus importantes de l'acémétacine sont celles mentionnées ci-après.

L'acémétacine montre une activité anti-inflammatoire plus intense que l'indométacine. La DE50 (dose efficace 50) est 1 à 4 fois celle de l'indométacine sur les modèles expérimentaux étudiés - nystatine, concanavaline A, levures, formol, carraghénine, kaolin. Il en est de même pour l'arthrite par adjuvant de Freund et le test de Mizushima. Au contraire, l'acémétacine est peu puissante en tant qu'inhibiteur de la synthèse de prostaglandines (environ 30 fois moins puissante que l'indométacine).

L'action analgésique est également bien documentée par la preuve de benzoquinone et le test de Randall Selitto, ainsi que par les nombreuses études cliniques.

L'administration chronique ne conditionne pas la tolérance ni la dépendance.

Propriétés pharmacocinétiques:

L'acémétacine est presque complètement résorbée par voie orale (presque 100% de biodisponibilité). Les concentrations maximales sont atteintes environ 2 heures suivant l'administration.

L'acémétacine est partiellement éliminée par voie rénale, de manière libre, glucuroconjugée, ou transformée en indométacine et métabolites O-déméthylés et N-désacylés (libres et conjugués). L'acémétacine et ses métabolites sont également partiellement excrétés par voie biliaire et éliminés dans les fèces. L'élimination biliaire s'effectue essentiellement sous forme d'acémétacine libre et glucuroconjugée. Il n'y a pas d'induction d'enzymes métabolisatrices, même en cas de traitement prolongé. Les administrations répétées conditionnent des niveaux plasmatiques plus élevés. Ainsi, l'équilibre est établi au bout d'environ 7 jours, ne constatant aucune accumulation ultérieure.

Suite à l'administration unique ou continuée, la relation entre les concentrations sanguines du médicament intact et de l'indométacine découlant de sa métabolisation est de 1:1. Les concentrations de l'acémétacine dans le liquide synovial et la membrane synoviale sont respectivement 2 et 4 fois supérieures à celles rencontrées dans le plasma.

15. Indications

Traitement symptomatique de situations douloureuses/inflammatoires aiguës ou chroniques et d'exacerbations de pathologie chronique, notamment :

- Affections rhumatismales (arthrite rhumatoïde, spondylarthrites séronégatives).
- Tendinites, ténosynovites, bursites.
- Crises de goutte aiguës, lumbago, sciatique.
- Ostéoarthrose.
- Situations traumatiques : distensions, entorses, contusions.

16. Mode d'action

L'activité anti-inflammatoire découle de l'association de plusieurs actions que ce dérivé indolique exerce à différentes phases de la réaction inflammatoire, produisant ainsi une inhibition de libération d'enzymes lysosomales, d'activation d'enzymes protéolytiques, de libération de l'histamine des mastocytes, de libération de la bradycinine et de la sérotonine, du complément, de l'exsudation et de la migration leucocytaire. Elle est en outre responsable de l'inhibition du système de la cyclo-oxygénase, avec action préférentielle sur la COX 2.

17. Mode d'emploi et posologie

Posologie

La dose moyenne normale pour l'adulte est de 60 mg, 2 à 3 fois par jour.

Dans le traitement de crises de goutte aiguës, la dose initiale pourra être de 120 mg, suivie de 60 mg toutes les 8 heures.

Ne pas dépasser un traitement de 7 jours pour toute administration supérieure à 180 mg.

La survenue d'effets indésirables peut être minimisée par l'utilisation de la dose minimale efficace pendant la durée la plus courte possible nécessaire au soulagement des symptômes.

Insuffisance rénale et hépatique

Prendre des précautions lors de l'administration d'un AINS à des patients souffrant d'insuffisance rénale et hépatique. Chez les patients atteints de dysfonction rénale et hépatique légère à modérée, la dose initiale devra être réduite. Ne pas administrer l'acémétacine aux patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique grave.

Enfants et adolescents

La prise de RANTUDIL n'est pas recommandée aux enfants et adolescents âgés moins de 14 ans.

Mode d'administration

Les gélules doivent être ingérées entières, avec un peu de liquide, de préférence de préférence suivant la consommation d'un aliment.

18. Contre-indications

Hypersensibilité à l'acémétacine ou à l'un des excipients.

Histoire d'hémorragie gastro-intestinale ou perforation associée à la thérapeutique précédente à base d'AINS. Ulcère peptique/hémorragie active ou histoire d'ulcère peptique/hémorragie récurrente (deux ou plusieurs épisodes différents d'ulcération ou hémorragie prouvée).

En cas d'insuffisance hépatique, rénale ou cardiaque grave.

Comme tout autre anti-inflammatoire non-stéroïde (AINS), RANTUDIL est également contre-indiqué aux patients dont les crises d'asthme, d'urticaire ou de rhinite aiguë sont provoquées par l'acide acétylsalicylique ou par tout autre AINS.

Patients présentant une hémorragie cérébrovasculaire ou d'autres hémorragies actives.

Patients atteints de modifications inexplicables de l'hématopoïèse ou du système de coagulation.

Dernier trimestre de grossesse.

19. Précautions d'emploi et mise en garde

Il est possible de minimiser les effets indésirables en administrant la dose minimale efficace pendant la durée la plus courte possible nécessaire pour contrôler les symptômes.

Patients âgés

Les personnes âgées présentent plus fréquemment des réactions adverses aux AINS, notamment des cas d'hémorragies gastro-intestinales et de perforations, lesquelles peuvent s'avérer être fatales.

Hémorragie, ulcération et perforation gastro-intestinale

Des cas d'hémorragie, d'ulcération et de perforation gastro-intestinale potentiellement fatale ont été rapportés avec tous les AINS, à plusieurs phases du traitement, qu'ils soient ou non associés à des symptômes d'alerte ou histoire d'événements gastro-intestinaux graves. Le risque d'hémorragie, d'ulcération ou de perforation est plus grand avec des doses élevées d'AINS, chez les patients ayant une histoire d'ulcère peptique, particulièrement associée à l'hémorragie ou perforation et chez les patients âgés.

Dans ces cas, les patients devront être avertis d'informer leur médecin de la survenue de symptômes abdominaux et d'hémorragie digestive, surtout au cours des phases initiales du traitement.

Chez ces patients, commencer le traitement par la dose minimale efficace. La coadministration d'agents protecteurs (ex. : misoprostol ou inhibiteurs de la pompe de protons) devra être pondérée pour ces patients, ainsi que pour ceux devant simultanément prendre l'acide acétylsalicylique à de faibles doses, ou d'autres médicaments pouvant augmenter le risque d'ulcère ou d'hémorragie, comme les corticostéroïdes, les anticoagulants (comme la warfarine), les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ou des antiagrégants plaquettaires, comme l'acide acétylsalicylique. Interrompre le traitement en cas d'hémorragie gastro-intestinale ou d'ulcération chez les patients prenant RANTUDIL.

Les AINS doivent être administrés avec précaution chez les patients ayant une histoire de maladie inflammatoire de l'intestin (colite ulcéreuse, maladie de Crohn), dans la mesure où ces situations peuvent être exacerbées.

Effets hépatiques

Un contrôle médical rigoureux est nécessaire lors de la prescription de RANTUDIL chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique. En effet, leur condition pourra être exacerbée.

Comme tout autre AINS, des augmentations des niveaux d'une ou de plusieurs enzymes hépatiques pourront survenir. Lors d'un traitement de longue durée avec RANTUDIL il est conseillé un contrôle fréquent de la fonction hépatique, en tant que mesure de précaution. Si les tests de la fonction hépatique restent anormaux ou se détériorent, s'il apparaît des signes ou symptômes cliniques suggérant une maladie hépatique ou s'il se produit d'autres phénomènes (par exemple, éosinophilie, l'exanthème, etc.), il convient d'interrompre l'administration de RANTUDIL. Une hépatite peut survenir en l'absence de symptômes prodromiques.

Effets rénaux

À cause des cas rapportés d'œdème ou de rétention de liquides découlant de la thérapeutique à base d'AINS, porter une attention particulière aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque ou rénale, ayant un historique d'hypertension, aux personnes âgées, aux patients recevant un traitement concomitant à base de diurétiques ou de médicaments pouvant considérablement modifier la fonction rénale. Ainsi, et dans ces situations, on recommande, à titre de précaution, de contrôler la fonction rénale en cas de prise de RANTUDIL. L'interruption de la thérapeutique est normalement suivie d'un retour à l'état de prétraitement.

Effets hématologiques

De même que les autres AINS, et en cas de traitement de longue durée par le RANTUDIL, il est recommandé de faire un contrôle sanguin.

Comme c'est le cas pour les autres AINS, RANTUDIL peut temporairement inhiber l'agrégation plaquettaire. Une surveillance attentive s'impose chez les patients présentant de troubles de l'hématose.

Des réactions adverses cutanées graves, dont certaines fatales, y compris la dermatite exfoliative, un syndrome de Stevens-Johnson et une nécrolyse épidermique toxique, ont été très rarement signalées comme conséquence d'un traitement par des AINS. Apparemment, le risque de survenue de ces réactions est plus élevé au début du traitement. Ainsi, dans la plupart des cas, ces réactions se manifestent au cours du premier mois de traitement, menant à l'arrêt de RANTUDIL dès l'apparition des premiers symptômes d'éruption, de lésions muqueuses ou d'autres réactions d'hypersensibilité.

Effets cardiovasculaires et cérébrovasculaires

Des cas de rétention de liquides et d'œdème associés au traitement par AINS ont été rapportés. Ainsi, une surveillance adéquate et des recommandations sont requises chez les patients présentant des antécédents d'hypertension artérielle et/ou d'insuffisance cardiaque congestive légère à modérée.

Les données des études cliniques et épidémiologiques suggèrent que l'administration de certains AINS (notamment à des doses élevées et pendant un traitement de longue durée) peut être associée à une légère augmentation du risque d'événements thrombotiques artériels (par exemple, infarctus du myocarde ou AVC). Il n'y a pas de données suffisantes pour éliminer le risque de survenue de ces effets lors de l'utilisation de l'acémétacine.

Les patients présentant une hypertension artérielle non contrôlée, une insuffisance cardiaque congestive, une cardiopathie ischémique établie, une maladie artérielle périphérique et/ou de maladie cérébrovasculaire ne devront être traités par l'acémétacine qu'après un examen attentif. Des précautions similaires doivent être portées avant tout initiation d'un traitement à long terme chez les patients présentant des facteurs de risques cardiovasculaires (ex. : hypertension artérielle, hyperlipidémie, un diabète mellitus ou une consommation tabagique).

Asthme préexistant

Les réactions aux AINS, comme les exacerbations asthmatiques, l'œdème de Quincke ou l'urticaire sont plus fréquentes chez les patients atteints d'asthme, de rhinite allergique saisonnière, d'inflammation des muqueuses nasales (p. ex. polypes nasaux), de maladies pulmonaires obstructives chroniques ou d'infections chroniques du tract respiratoire (surtout si celles-ci s'accompagnent de symptômes similaires à ceux de la rhinite allergique) que chez les autres patients. Dès lors, il est recommandé une attention particulière chez ces patients (mesures d'urgence). Cela s'applique également aux patients qui présentent une allergie à d'autres substances, comme les réactions cutanées, le prurit ou l'urticaire.

RANTUDIL ne doit être pris qu'après une évaluation attentive du bénéfice-risque chez les patients atteints de lupus érythémateux systémique (LES) ou de maladies mixtes du tissu conjonctif. En effet, il peut y avoir un risque accru de méningite aseptique.

Ne pas prendre de doses de RANTUDIL supérieures à celles recommandées. La prise de RANTUDIL n'est pas recommandée aux enfants et adolescents de moins de 14 ans.

Éviter l'administration concomitante de RANTUDIL avec d'autres AINS, y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2.

Tout comme avec un AINS, l'acémétacine peut masquer les signes et symptômes d'une infection.

Des altérations oculaires pourront survenir, lesquelles seront plus fréquentes chez les patients atteints d'arthrite rhumatoïde. Ainsi, en cas de traitement prolongée, consultez votre ophtalmologue et interrompez le traitement en cas de manifestation.

Des cas d'hypercalcémie ont été rapportés chez les patients traités à l'indométacine et à l'acémétacine. Ainsi, ce facteur devra être pris en compte pour les cas d'utilisation de diurétiques épargneurs de potassium.

RANTUDIL contient du lactose monohydraté. Les patients ayant des problèmes héréditaires rares d'intolérance au galactose, un trouble de lactase ou de malabsorption de glucose-galactose ne devront pas prendre ce médicament.

20. Effets secondaires / Effets indésirables

La fréquence a été définie comme suit :

[Très fréquents ($\geq 1/10$), Fréquents ($\geq 1/100$, $< 1/10$), Peu fréquents ($\geq 1/1.000$, $< 1/100$), Rares ($\geq 1/10.000$, $< 1/1.000$), Très rares ($< 1/10.000$, inconnu (ne peut être calculé à partir des données disponibles))]

Affections du système nerveux

Rares : céphalées, vertiges, troubles transitoires de la vue et de l'audition

Affections gastro-intestinales

Les événements adverses observés le plus fréquemment sont de nature gastro-intestinale. Les personnes âgées pourront notamment souffrir d'ulcères peptiques, de perforation ou d'hémorragie gastro-intestinale potentiellement fatale. Des cas de nausées, de dyspepsie, de vomissements, d'hématémèses, de flatulences, de douleurs abdominales, de diarrhée, de

constipation, de mélénas, de stomatite aphteuse, d'exacerbation de colite ou de la maladie de Crohn ont été rapportés suite à l'administration de ces médicaments. Des cas de gastrite ont été observés moins fréquemment.

Affections hépatobiliaires

Élévation occasionnelle des paramètres de laboratoire de la fonction hépatique.

Très rares : Symptômes de cholestase.

Affections cardiaques

Des cas d'œdème, d'hypertension et d'insuffisance cardiaque ont été rapportés pendant le traitement par les AINS.

Les données des essais cliniques et épidémiologiques suggèrent que l'administration de certains AINS (notamment à des doses élevées et en traitement de longue durée) pourra être associée à une légère hausse du risque d'événements thrombotiques artériels (par exemple, infarctus du myocarde et AVC).

Affections hématologiques et du système lymphatique

Rarement, thrombopénie, leucopénie et réduction des niveaux d'hémoglobine.

Très rares : agranulocytose réversible et dépression de la moelle osseuse.

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Très rares : Éruptions bulleuses, y compris le syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique.

Affections oculaires/affections de l'ouïe et du labyrinthe

Peu fréquents : tinnitus, vision trouble, douleur oculaire.

21. Incompatibilités

Sans objet.

22. Délai de péremption, condition de stockage e autres précautions

5 ans. À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C

23. Prix grossiste et Prix CAF Cameroun

PGHT: 2.952,00 FCFA

PGHT (CIF- voie maritime) = 3.100,00 FCFA

PGHT (CIF- voie aérienne) = 3.247,00 FCFA

24. Prix grossiste et public du pays fabricant convertis en monnaie camerounaise

Cette présentation n'est pas commercialisée au Portugal.